ВСЯКА СЕДМИЦА ПО ЕДИН СЛУЧАЙ™ · БОНУС 1

100 коментирани въпроса по случаи

Кратки клинични данни, един въпрос, четири отговора. 100 случая в 10 блока; в края на всеки блок — ключ с отговорите и кратък коментар защо отговорът е верен.

Библията на ортодонта

Съдържание

Как се решава

Блок 1 · Основна диагностика и класификация · Въпроси 1–10

Блок 2 · Цефалометрия · Въпроси 11–20

Блок 3 · Планиране и време на лечение · Въпроси 21–30

Блок 4 · Управление на мястото · Въпроси 31–40

Блок 5 · Анкораж и мини винтове · Въпроси 41–50

Блок 6 · Клас II · Въпроси 51–60

Блок 7 · Клас III · Въпроси 61–70

Блок 8 · Вертикални и трансверзални проблеми · Въпроси 71–80

Блок 9 · Помощни механики · Въпроси 81–90

Блок 10 · Финиширане, ретенция, травма и анкилоза · Въпроси 91–100

Следваща стъпка

НАЧАЛО

Как се решава

Един блок отнема около 15 минути. По един блок седмично, успоредно с 52-седмичната програма.

1. **Решете блока с отчитане на времето.** Записвайте отговорите до въпроса; не гледайте ключа с отговорите.
2. **Сравнете с ключа.** Прочетете коментара на въпросите, на които сте отговорили грешно или вярно, но без да сте сигурни.
3. **Върнете се към източника.** В началото на всеки блок са посочени съответният модул от Библията и номерата на визуалните карти.
4. **Запишете резултата си.** На реда в края на блока запишете броя верни отговори и датата; след месец решете същия блок отново.

БЛОК	ТЕМА	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕДМИЦА
1–2	Основна диагностика, цефалометрия	По време на или след седмица 1–11
3	Планиране и време на лечение	Седмица 12–16
4–5	Управление на мястото, анкораж и мини винтове	Седмица 17–23
6–7	Клас II, клас III	Седмица 24–31
8	Вертикални и трансверзални проблеми	Седмица 32–38
9	Помощни механики	Седмица 39–43
10	Финиширане, ретенция, травма и анкилоза	Седмица 44–52

Случаите са с образователна цел

Данните са измислени и опростени, за да проверят едно понятие. При реален пациент решението се взема след пълен преглед и записи.

БЛОК 1 · ВЪПРОСИ 1–10

Основна диагностика и класификация

За четене: Модул 01 и Модул 02 · Визуални карти 1, 2, 9, 10, 17, 37, 38

Въпрос 1

СЛУЧАЙ

13 г. Моларно съотношение двустранно пълен клас II. Overjet 8 mm, горните резци са проклинирани.

Каква е класификацията по Angle?

A) Клас II, подклас 1

B) Клас I

C) Клас II, подклас 2

D) Клас III

Въпрос 2

СЛУЧАЙ

15 г. Моларно съотношение клас II. Горните централни резци са ретроклинирани, латералните — проклинирани, дълбок overbite.

Коя е най-вероятната класификация?

A) Клас II, подклас 1

B) Клас I с дълбока захапка

C) Псевдо клас III

D) Клас II, подклас 2

Въпрос 3

СЛУЧАЙ

10 г. Вдясно моларно съотношение клас I, вляво половин клас II. Долната средна линия е изместена 2 mm наляво.

Какво трябва да се направи първо?

A) Незабавно започване на ластици клас II вляво

B) Планиране на екстракция на горен ляв премолар

C) Проверка на захапката в централна релация и разграничаване на функционалното изместване от истинската асиметрия

D) Изчакване една година без никаква намеса

Въпрос 4

СЛУЧАЙ

9 г. Задна кръстосана захапка вдясно. В централна релация средните линии съвпадат, в централна оклузия долната средна линия се измества надясно.

Каква е най-вероятната диагноза?

A) Истинска мандибуларна асиметрия

B) Функционално изместване поради стеснение на горната челюст

C) Дентална кръстосана захапка на един зъб

D) Анкилоза на ТМС

Въпрос 5

СЛУЧАЙ

25 г. В покой горните резци се виждат прекомерно. Дължината на горната устна и на коронките е нормална. При усмивка гингивата е изразено видима.

Коя причина се обмисля най-често?

A) Вертикален максиларен излишък или горна дентоалвеоларна екструзия

B) Къса горна устна

C) Пасивен пробив

D) Мандибуларна ретрузия

Въпрос 6

СЛУЧАЙ

11 г. Десният горен кучешки зъб не се палпира букално, левият се палпира. Млечният кучешки зъб е на място.

Кой е правилният подход?

A) Изчакване две години без никакви записи

B) Незабавно хирургично откриване и започване на тракция

C) Оставяне на млечния кучешки зъб без контрол

D) Оценка на позицията с панорамна снимка и при нужда планиране на допълнителна (3D) образна диагностика

Въпрос 7

СЛУЧАЙ

В долната дъга има скупченост 7 mm. Долната крива на Spee е около 3 mm.

Как най-добре се тълкува общата нужда от място в долната дъга?

A) Точно 7 mm

B) 4 mm, кривата на Spee осигурява място

C) Повече от 7 mm; изправянето на кривата на Spee също изисква място

D) Кривата на Spee не се отчита в анализа на мястото

Въпрос 8

СЛУЧАЙ

При анализа на Bolton предното съотношение е високо: долните фронтални зъби са големи спрямо горните.

Кое решение се обмисля като опция?

A) Несъответствието по Bolton няма клиничен ефект

B) IPR в долния фронт или възстановително уголемяване на горните латерални резци

C) Екстракцията на горни премолари е задължителна

D) Необходимо е бързо разширение на горната челюст

Въпрос 9

СЛУЧАЙ

14 г. При отваряне на устата девиация наляво, щракане в дясната ТМС. Няма болка.

Какво се прави преди лечението?

A) Находката се записва в началната документация, пациентът и семейството се информират, при нужда се назначава допълнителна оценка

B) Да не се отбелязва, защото няма болка

C) Категоричен отказ от лечение

D) Незабавно поставяне на функционален апарат

Въпрос 10

СЛУЧАЙ

8 г. Скупченост около 2 mm в долните постоянни резци. Млечният кучешки зъб и млечните молари са на място.

Кое е правилното тълкуване?

A) Задължително е нужна екстракция на премолари

B) Бързото разширение на горната челюст е задължително

C) Трябва незабавно да се започне лечение с фиксиран апарат

D) Често е в смесеното съзъбие; проследява се с анализ на мястото и leeway пространството

Блок 1 · Отговори и коментари

ВЪПРОС	ОТГОВОР	КОМЕНТАР
1	**A**	**Клас II, подклас 1.** Увеличеният overjet и проклинираните горни резци показват подклас 1. Скелетният произход се оценява отделно с цефалометрия.
2	**D**	**Клас II, подклас 2.** Ретроклинираните централни, проклинираните латерални резци и дълбоката захапка са типичният модел на подклас 2.
3	**C**	**Проверка на захапката в централна релация и разграничаване на функционалното изместване от истинската асиметрия.** Едностранната разлика в класа и изместването на средната линия първо изискват проверка CR-CO; механиката се избира едва след изясняване на причината.
4	**B**	**Функционално изместване поради стеснение на горната челюст.** Изравняването на средните линии в централна релация е основната находка при функционално изместване.
5	**A**	**Вертикален максиларен излишък или горна дентоалвеоларна екструзия.** Ако дължината на устната и на коронките е нормална, при гингивална усмивка на преден план излизат вертикални максиларни и дентоалвеоларни причини.
6	**D**	**Оценка на позицията с панорамна снимка и при нужда планиране на допълнителна (3D) образна диагностика.** Едностранната невъзможност за палпиране е предупредителен знак за ретиниран кучешки зъб; първо се оценяват позицията и съседните корени.
7	**C**	**Повече от 7 mm; изправянето на кривата на Spee също изисква място.** Изправянето на дълбока крива на Spee изисква допълнително място по периметъра на дъгата.
8	**B**	**IPR в долния фронт или възстановително уголемяване на горните латерални резци.** Несъответствието в размера на зъбите влияе върху overjet и контактите при финиширането; може да се балансира с IPR или възстановителна корекция.
9	**A**	**Находката се записва в началната документация, пациентът и семейството се информират, при нужда се назначава допълнителна оценка.** Находките в ТМС трябва да се документират преди началото на лечението; пациентът се информира и при нужда се прави допълнителна оценка.
10	**D**	**Често е в смесеното съзъбие; проследява се с анализ на мястото и leeway пространството.** В ранното смесено съзъбие леката скупченост на долните резци е често; решава се с проследяване и анализ на мястото.

Верни отговори: ___ / 10 Дата: Дата на повторение:

БЛОК 2 · ВЪПРОСИ 11–20

Цефалометрия

За четене: Модул 02 · Визуални карти 3, 40, 41, 42 · Тетрадка за упражнения по цефалометрични измервания

Въпрос 11

СЛУЧАЙ

SNA 82°, SNB 76°, ANB 6°.

Кое е най-точното тълкуване?

A) Скелетен клас II с преобладаваща максиларна прогнатия

B) Скелетен клас I

C) Скелетен клас III

D) Скелетен клас II с преобладаваща мандибуларна ретрузия

Въпрос 12

СЛУЧАЙ

SNA 86°, SNB 80°, ANB 6°.

Кое е най-точното тълкуване?

A) Скелетен клас II с преобладаваща мандибуларна ретрузия

B) Скелетен клас III

C) Скелетен клас II с преобладаваща максиларна прогнатия

D) Нормално сагитално съотношение

Въпрос 13

СЛУЧАЙ

ANB 2°, Wits +5 mm. Равнината SN изглежда с изразен наклон.

Как трябва да се тълкува?

A) Тъй като ANB е нормален, пациентът със сигурност е скелетен клас I

B) ANB може да е подвеждащ; оценява се заедно с Wits, профила и другите измервания

C) Стойността на Wits няма клинично значение

D) Наклонът на SN не влияе на ANB

Въпрос 14

СЛУЧАЙ

FMA 34°, SN-GoMe 40°.

Какъв е вертикалният модел?

A) Хипердивергентен

B) Хиподивергентен

C) Нормодивергентен

D) Не може да се оцени с тези стойности

Въпрос 15

СЛУЧАЙ

FMA 18°. Дълбок overbite.

Кое твърдение е вярно за този вертикален модел?

A) Екструзията на моларите е абсолютно противопоказана

B) Рискът от отворена захапка е висок

C) За вертикален контрол приоритет е задната интрузия

D) Задната екструзия се толерира по-добре, но склонността към дълбока захапка е голяма

Въпрос 16

СЛУЧАЙ

IMPA 102°. За камуфлаж на клас II се планират продължителни ластици клас II.

Кой е най-важният риск?

A) Ретроклинация на долните резци

B) Интрузия на горните молари

C) Още по-голяма проклинация на долните резци; пародонтален риск и риск за стабилността

D) Спонтанно увеличаване на overbite

Въпрос 17

СЛУЧАЙ

U1-SN 115°. Overjet 8 mm, ANB 3°.

Кое е най-точното тълкуване на overjet?

A) Overjet е изцяло скелетен

B) Значителна част от overjet се дължи на проклинацията на горните резци

C) Горните резци са ретроклинирани

D) Инклинацията на резците няма връзка с overjet

Въпрос 18

СЛУЧАЙ

Пациент с клас III. ANB −3°, IMPA 80°, U1-SN 112°.

Какво показват инклинациите на резците?

A) Естествена дентоалвеоларна компенсация: горните резци са проклинирани, долните — ретроклинирани

B) Декомпенсацията е завършена

C) И двата резеца са с нормална инклинация

D) Горните резци са ретроклинирани, долните — проклинирани

Въпрос 19

СЛУЧАЙ

При трасирането чертаете мандибуларната равнина.

През кои точки минава мандибуларната равнина за ъгъла SN-GoMe?

A) Porion и Orbitale

B) Sella и Nasion

C) ANS и PNS

D) Gonion и Menton

Въпрос 20

СЛУЧАЙ

За да измерите FMA, чертаете франкфуртската хоризонтала.

С кои точки се определя франкфуртската равнина?

A) Sella и Nasion

B) ANS и PNS

C) Porion и Orbitale

D) Gonion и Menton

Блок 2 · Отговори и коментари

ВЪПРОС	ОТГОВОР	КОМЕНТАР
11	**D**	**Скелетен клас II с преобладаваща мандибуларна ретрузия.** SNA нормален, SNB нисък: разликата идва от мандибулата.
12	**C**	**Скелетен клас II с преобладаваща максиларна прогнатия.** SNB нормален, SNA висок: разликата идва от максилата.
13	**B**	**ANB може да е подвеждащ; оценява се заедно с Wits, профила и другите измервания.** ANB се влияе от наклона на равнината SN и от позицията на Nasion; при несъответствие решаващи са допълнителните измервания.
14	**A**	**Хипердивергентен.** И двата ъгъла са значително над класическите норми (FMA около 25°, SN-GoMe около 32°).
15	**D**	**Задната екструзия се толерира по-добре, но склонността към дълбока захапка е голяма.** Хиподивергентният модел толерира задна екструзия; трябва да се има предвид склонността към дълбока захапка и рецидив.
16	**C**	**Още по-голяма проклинация на долните резци; пародонтален риск и риск за стабилността.** Ластиците клас II проклинират долните резци; при вече проклинирани резци това е ограничаващ фактор.
17	**B**	**Значителна част от overjet се дължи на проклинацията на горните резци.** U1-SN е значително над нормата, ANB е на границата на нормата: преобладава денталният компонент.
18	**A**	**Естествена дентоалвеоларна компенсация: горните резци са проклинирани, долните — ретроклинирани.** При клас III резците се накланят така, че да прикрият скелетното несъответствие; в хирургичния план тази компенсация се премахва.
19	**D**	**Gonion и Menton.** SN-GoMe е ъгълът между равнината SN и равнината Go-Me.
20	**C**	**Porion и Orbitale.** Франкфуртската хоризонтала минава през Porion и Orbitale.

Верни отговори: ___ / 10 Дата: Дата на повторение:

БЛОК 3 · ВЪПРОСИ 21–30

Планиране и време на лечение

За четене: Модул 03 · Визуални карти 19, 43–52 · Инструмент 4

Въпрос 21

СЛУЧАЙ

13 г. Клас II, подклас 1, дълбока захапка, лека скупченост. Ще напишете списъка на проблемите.

Кой е правилният подход?

A) Първо се избира апаратът и проблемите се описват според него

B) Записване само на оплакването на пациента

C) Проблемите се записват поотделно в рубриките сагитални, вертикални, трансверзални и място, след което се приоритизират

D) Изброяване само на цефалометричните стойности

Въпрос 22

СЛУЧАЙ

8 г. Един горен резец е в предна кръстосана захапка. В централна релация може да застане ръб в ръб. На долния резец е започнала гингивална рецесия.

Кое е най-подходящото решение?

A) Изчакване до завършване на постоянното съзъбие

B) Оценка за ранна корекция

C) Планиране на ортогнатна хирургия

D) Даване само на нощна плака

Въпрос 23

СЛУЧАЙ

7 г. Лека тенденция към клас II, overjet 4 mm, без анамнеза за травма. Детето още не е готово за лечение.

Кой е най-подходящият подход?

A) Проследяване и повторна оценка в периода на растеж

B) Незабавно започване на лечение с фиксиран апарат

C) Планиране на екстракция на горни премолари

D) Назначаване на хирургична консултация

Въпрос 24

СЛУЧАЙ

18 г., мъж. Клас III. ANB −6°, Wits −10 mm. Изразено оплакване от профила.

Коя е най-подходящата първа стъпка?

A) Незабавно започване на камуфлаж с ластици клас III

B) Препоръка за лицева маска

C) Проследяване, без да се предлага никаква опция

D) Потвърждаване, че растежът е завършил, и препоръка за консултация за ортогнатна хирургия

Въпрос 25

СЛУЧАЙ

16 г., момиче. Клас II, ANB 5°, профилът е приемлив. Няма скупченост в долната дъга, растежът е до голяма степен завършен.

Коя опция може да се обмисли?

A) Екстракцията на четири премолара е задължителна

B) Лицева маска

C) Камуфлаж с екстракция на горни премолари

D) Само бързо разширение на горната челюст

Въпрос 26

СЛУЧАЙ

14 г. Половин клас II. Слабо сътрудничество с ластиците и подвижния апарат.

Кое зависи най-малко от сътрудничеството?

A) Подвижен функционален апарат

B) Фиксиран функционален апарат или механика с опора на мини винтове

C) Ластици клас II

D) Подвижна плака за нощно носене

Въпрос 27

СЛУЧАЙ

40 г. Има пародонтална костна загуба и активно възпаление.

Кога се започва ортодонтско лечение?

A) След завършване на пародонталното лечение и стабилизиране на заболяването

B) Веднага; ортодонтията намалява възпалението

C) Никога не може да се започне

D) Само след поставяне на имплантите

Въпрос 28

СЛУЧАЙ

Вродено липсващ горен десен латерален резец. Формата и цветът на кучешкия зъб са подходящи, нивото на гингивата е различно.

Как се решава дали пространството да се затвори или отвори?

A) Винаги се отваря място за имплант

B) Пространството винаги се затваря

C) Решението е само на протезиста

D) С екипно решение, като се оценят заедно морфологията на кучешкия зъб, цветът, нивото на гингивата, оклузията и профилът

Въпрос 29

СЛУЧАЙ

Планирате последователността на механиката.

Коя е правилната последователност?

A) Финиширане → нивелиране → работна фаза → ретенция

B) Работна фаза → нивелиране → ретенция → финиширане

C) Нивелиране и подреждане → работна фаза → финиширане → ретенция

D) Ретенция → нивелиране → финиширане → работна фаза

Въпрос 30

СЛУЧАЙ

Подготвяте VTO при възрастен пациент.

Каква е основната цел на VTO?

A) Гарантиране на категоричен резултат

B) Предварително да се види възможният ефект на планираните промени върху профила и оклузията

C) Замяна на формуляра за информирано съгласие, който използва Вашата клиника

D) Цефалометрията става излишна

Блок 3 · Отговори и коментари

ВЪПРОС	ОТГОВОР	КОМЕНТАР
21	**C**	**Проблемите се записват поотделно в рубриките сагитални, вертикални, трансверзални и място, след което се приоритизират.** Списъкът на проблемите се пише по равнини; механиката се избира последна.
22	**B**	**Оценка за ранна корекция.** Функционалното изместване и пародонталното натоварване са класически основания за ранно лечение.
23	**A**	**Проследяване и повторна оценка в периода на растеж.** Ако няма основание за ранно лечение, еднофазното лечение в подходящия момент често е по-ефективно.
24	**D**	**Потвърждаване, че растежът е завършил, и препоръка за консултация за ортогнатна хирургия.** Голямото скелетно несъответствие и оплакването от профила изискват обсъждане на хирургична опция.
25	**C**	**Камуфлаж с екстракция на горни премолари.** Ако долната дъга е подредена, може да се планира камуфлаж само с горни екстракции и финиширане в моларен клас II.
26	**B**	**Фиксиран функционален апарат или механика с опора на мини винтове.** При слабо сътрудничество на преден план излизат опции, които не зависят от това дали пациентът поставя и сваля апарата.
27	**A**	**След завършване на пародонталното лечение и стабилизиране на заболяването.** При активна пародонтална болест движението на зъбите може да ускори костната загуба.
28	**D**	**С екипно решение, като се оценят заедно морфологията на кучешкия зъб, цветът, нивото на гингивата, оклузията и профилът.** При липсващ латерален резец няма едно правилно решение; естетичните, оклузалните и пародонталните критерии се преценяват заедно.
29	**C**	**Нивелиране и подреждане → работна фаза → финиширане → ретенция.** Преди завършване на нивелирането не се преминава към ригидни работни дъги и затваряне на пространствата.
30	**B**	**Предварително да се види възможният ефект на планираните промени върху профила и оклузията.** VTO е инструмент за планиране; не е гаранция за резултат.

Верни отговори: ___ / 10 Дата: Дата на повторение:

БЛОК 4 · ВЪПРОСИ 31–40

Управление на мястото

За четене: Модул 04 · Визуални карти 14, 16, 18, 53–61 · Инструмент 2

Въпрос 31

СЛУЧАЙ

17 г. Клас I. Долу скупченост 9 mm, бимаксиларна протрузия, устните са напред.

Коя е най-силната опция?

A) Само IPR

B) План с екстракции

C) План без екстракция с още по-голямо изнасяне на резците напред

D) Само проследяване

Въпрос 32

СЛУЧАЙ

26 г. Скупченост 2,5 mm в долните резци. Триъгълна форма на коронките, добра устна хигиена.

Коя опция е подходяща?

A) IPR

B) Екстракция на четири премолара

C) Бързо разширение на горната челюст

D) Ортогнатна хирургия

Въпрос 33

СЛУЧАЙ

Висок кариесен риск, недостатъчна устна хигиена и малки коронки. Лека скупченост в долните резци.

Кое е правилното решение за IPR?

A) Максимално възможно количество IPR

B) Оставяне на IPR без полиране

C) Пренебрегване на рисковите фактори

D) Избягване на IPR или силното му ограничаване

Въпрос 34

СЛУЧАЙ

10 г. Двустранна задна кръстосана захапка. Тясна горна челюст, дълбоко небце.

Коя е най-подходящата опция?

A) Само кръстосани ластици

B) Стесняване на долната дъга

C) Бързо разширение на горната челюст (RME)

D) Изчакване до края на растежа

Въпрос 35

СЛУЧАЙ

22 г. Скелетно трансверзално стеснение. Тънка букална кост, тънък гингивален фенотип.

Кой подход е по-правилен?

A) Разширение само чрез букално накланяне на зъбите

B) Оценка на разширение с опора на мини винтове или хирургично асистирано разширение с мнение на пародонтолог

C) Прилагане на RME без никаква оценка

D) Пренебрегване на трансверзалното стеснение

Въпрос 36

СЛУЧАЙ

9 г. Долният ляв втори млечен молар е загубен рано. До пробива на подлежащия премолар има още време. Все още няма загуба на място.

Коя е най-подходящата опция?

A) Поддържател на място

B) Да не се прави нищо

C) Незабавна екстракция на премолари

D) Ластици клас III

Въпрос 37

СЛУЧАЙ

11 г. Долните втори млечни молари са още на място. Скупченост 3 mm в долните резци.

Коя опция може да допринесе за печелене на място?

A) Ранна екстракция на млечните молари

B) Екстракция на долни резци

C) Бързо разширение на горната челюст

D) Лингвална дъга за запазване на leeway пространството

Въпрос 38

СЛУЧАЙ

Прави се дистализация на горните молари.

Кой е очакваният страничен ефект в анкоражната единица?

A) Ретроклинация на резците

B) Дистализация на долните молари

C) Мезиално движение на премоларите и резците и проклинация на резците

D) Спонтанно увеличаване на overbite

Въпрос 39

СЛУЧАЙ

16 г. Клас II, подклас 1. Долната дъга е подредена. Ще се екстрахират само горните първи премолари.

Какво моларно и кучешко съотношение се цели при финиширането?

A) Моларен клас I, кучешки клас I

B) Моларен клас II, кучешки клас I

C) Моларен клас III, кучешки клас II

D) Моларен клас I, кучешки клас II

Въпрос 40

СЛУЧАЙ

В долната дъга е нужна екстракция, но не се желае прекомерно връщане назад на долните резци.

Коя екстракция може да се предпочете?

A) Долен втори премолар

B) Долен първи премолар

C) Долен кучешки зъб

D) Долен централен резец

Блок 4 · Отговори и коментари

ВЪПРОС	ОТГОВОР	КОМЕНТАР
31	**B**	**План с екстракции.** Тежката скупченост и протрузията са две силни находки в полза на екстракция.
32	**A**	**IPR.** Леката скупченост и триъгълната форма на коронките са подходящи условия за IPR.
33	**D**	**Избягване на IPR или силното му ограничаване.** Кариесният риск и малкият размер на коронките са находки против IPR.
34	**C**	**Бързо разширение на горната челюст (RME).** В периода на растеж скелетното трансверзално стеснение може да се лекува с RME.
35	**B**	**Оценка на разширение с опора на мини винтове или хирургично асистирано разширение с мнение на пародонтолог.** При възрастен и тънък фенотип само денталното разширение повишава риска от загуба на гингива и кост.
36	**A**	**Поддържател на място.** При ранна загуба на млечен молар мезиалното движение на постоянния молар може да доведе до загуба на място.
37	**D**	**Лингвална дъга за запазване на leeway пространството.** Ако leeway пространството, освободено при смяната на млечните молари, бъде запазено, то може да допринесе за решаване на скупчеността.
38	**C**	**Мезиално движение на премоларите и резците и проклинация на резците.** Сила, равна и противоположна на дистализиращата, изтласква анкоражните зъби напред.
39	**B**	**Моларен клас II, кучешки клас I.** При екстракции само горе горните молари остават на място; кучешките зъби се довеждат до клас I.
40	**A**	**Долен втори премолар.** Екстракцията на втори премолари позволява по-малко връщане назад на долните резци и мезиално движение на моларите.

Верни отговори: ___ / 10 Дата: Дата на повторение:

БЛОК 5 · ВЪПРОСИ 41–50

Анкораж и мини винтове

За четене: Модул 04 · Визуални карти 11, 62–66

Въпрос 41

СЛУЧАЙ

Бимаксиларна протрузия. Екстракция на четири премолара; желае се максимално връщане назад на резците.

Коя е най-надеждната опция за анкораж?

A) Директен анкораж с мини винт

B) Еластична верижка без опора за анкораж

C) Само ластици клас II

D) Само нощна плака

Въпрос 42

СЛУЧАЙ

При затваряне на пространствата горните молари се придвижиха 3 mm мезиално, overjet намаля по-малко от очакваното.

Какъв е проблемът?

A) Коренова резорбция

B) Функционално изместване

C) Несъответствие по Bolton

D) Загуба на анкораж

Въпрос 43

СЛУЧАЙ

Обмисляте използване на TPA.

Кой е основният ефект на TPA?

A) Сам по себе си осигурява абсолютен сагитален анкораж

B) Интрудира долните резци

C) Запазва трансверзалното съотношение между моларите и контролира ротацията на моларите

D) Разширява скелетно горната челюст

Въпрос 44

СЛУЧАЙ

В горната дъга се планира апарат на Nance за допълнителен анкораж.

Къде се опира апаратът на Nance?

A) От долните резци

B) От акрилния бутон, опиращ се на мукозата на предното небце

C) От мини винтовете

D) От екстраоралната зона

Въпрос 45

СЛУЧАЙ

Планирате поставяне на мини винт.

Какво се проверява на първо място преди поставянето?

A) Разстоянието между корените и количеството кост; по възможност прикрепена гингива

B) Само зоната, която пациентът предпочита

C) Само цветът на брекетите

D) Не е нужна никаква рентгенологична оценка

Въпрос 46

СЛУЧАЙ

Мини винтът е подвижен няколко седмици след поставянето.

Кои са най-вероятните причини?

A) Възрастта на пациента винаги е единствената причина

B) Неподходящ цвят на ластиците

C) Промяна на типа брекети

D) Контакт с корен, недостатъчна кост или възпаление около винта

Въпрос 47

СЛУЧАЙ

Мини винтът е свързан с премолар и силата се прилага от премолара.

Какъв е този тип анкораж?

A) Директен анкораж

B) Екстраорален анкораж

C) Индиректен анкораж

D) Реципрочен анкораж

Въпрос 48

СЛУЧАЙ

Възрастен. Поради загуба на антагониста горният първи молар е екструдиран. За протезата е нужно вертикално място.

Каква механика може да се обмисли?

A) Още по-голяма екструзия на молара

B) Интрузия на молар с опора на мини винт

C) Ластици клас II

D) Бързо разширение на горната челюст

Въпрос 49

СЛУЧАЙ

Възрастен. Хипердивергентен модел, предна отворена захапка 3 mm.

Коя опция е насочена към вертикалния проблем?

A) Оценка на задна интрузия с мини винтове

B) Продължителни ластици клас II

C) Задна екструзия

D) Неконтролирано дентално разширение

Въпрос 50

СЛУЧАЙ

Около мини винта има гингивална хиперплазия и чувствителност.

Кой е първоначалният подход?

A) Увеличаване на силата

B) Пренебрегване на находката

C) Добавяне на втори винт до мини винта

D) Контрол на хигиената и възпалението; ако няма подобрение — отстраняване на мини винта и оценка на друга зона

Блок 5 · Отговори и коментари

ВЪПРОС	ОТГОВОР	КОМЕНТАР
41	**A**	**Директен анкораж с мини винт.** При случаите с максимален анкораж мини винтът е надеждна опция, изискваща най-малко сътрудничество.
42	**D**	**Загуба на анкораж.** Мезиалното движение на моларите и недостатъчното намаляване на overjet са типични находки при загуба на анкораж.
43	**C**	**Запазва трансверзалното съотношение между моларите и контролира ротацията на моларите.** TPA има ограничен принос към сагиталния анкораж; основният му ефект е трансверзален контрол и контрол на ротацията.
44	**B**	**От акрилния бутон, опиращ се на мукозата на предното небце.** Апаратът на Nance се опира на палатиналната мукоза с акрилен бутон; хигиената под бутона се контролира.
45	**A**	**Разстоянието между корените и количеството кост; по възможност прикрепена гингива.** Контактът с корен и недостатъчната кост са сред най-честите причини за неуспех.
46	**D**	**Контакт с корен, недостатъчна кост или възпаление около винта.** При подвижен мини винт се оценяват позицията, костта и хигиената; при нужда се поставя отново в друга зона.
47	**C**	**Индиректен анкораж.** При индиректния анкораж мини винтът стабилизира един зъб, а силата се прилага от този зъб.
48	**B**	**Интрузия на молар с опора на мини винт.** Мини винтът позволява интрузия на един молар, без да засяга съседните зъби.
49	**A**	**Оценка на задна интрузия с мини винтове.** Задната интрузия позволява ротация на мандибулата напред и нагоре и може да намали отворената захапка.
50	**D**	**Контрол на хигиената и възпалението; ако няма подобрение — отстраняване на мини винта и оценка на друга зона.** Възпалението повишава риска от неуспех; първо се оценяват хигиената и натоварването.

Верни отговори: ___ / 10 Дата: Дата на повторение:

БЛОК 6 · ВЪПРОСИ 51–60

Клас II

За четене: Модул 05 · Визуални карти 12, 15, 67–72, 77 · Инструмент 3

Въпрос 51

СЛУЧАЙ

12 г. Моларно съотношение клас II. ANB 2°. Горните резци са проклинирани.

Какъв е предимно този клас II?

A) Скелетен, мандибуларна ретрузия
B) Скелетен, максиларна прогнатия
C) Функционално изместване
D) Дентален

Въпрос 52

СЛУЧАЙ

11 г., момче. SNB 74°, ANB 7°, FMA 24°. Близо до пубертетния скок на растежа, сътрудничи.

Коя опция излиза на преден план?

A) Ортогнатна хирургия
B) Лицева маска
C) Функционален апарат
D) Само екстракция на долни премолари

Въпрос 53

СЛУЧАЙ

10 г. Overjet 10 mm. Анамнеза за травма и интерпозиция на долната устна.

Кое е най-подходящото решение?

A) Изчакване до завършване на постоянното съзъбие
B) Оценка за ранно намаляване на overjet
C) Само изнасяне на долните резци напред
D) Само проследяване

Въпрос 54

СЛУЧАЙ

Лечението с Twin Block продължава.

Кой е най-типичният дентоалвеоларен страничен ефект?

A) Проклинация на долните резци
B) Ретроклинация на долните резци
C) Проклинация на горните резци
D) Поява на задна кръстосана захапка

Въпрос 55

СЛУЧАЙ

Използват се ластици клас II.

Кое е типичен страничен ефект?

A) Ретроклинация на долните резци
B) Интрузия на горните молари
C) Увеличаване на overjet
D) Екструзия на долните молари и проклинация на долните резци

Въпрос 56

СЛУЧАЙ

FMA 35°. Клас II, лека тенденция към отворена захапка. Обмислят се продължителни ластици клас II.

Кое е правилното тълкуване?

A) При хипердивергентен пациент е най-безопасната опция

B) Няма ефект върху вертикалния размер

C) Нужно е внимание; екструзията на моларите може да ротира мандибулата назад и да влоши профила

D) Винаги затваря отворената захапка

Въпрос 57

СЛУЧАЙ

Клас II, подклас 2, дълбок overbite.

Какво се прави първо при лечението?

A) Незабавно започване на ластици клас II

B) Корекция на инклинацията на горните централни резци и отваряне на дълбоката захапка

C) Екстракция на долни резци

D) Първо се поставя ретенционен апарат

Въпрос 58

СЛУЧАЙ

При пациент с клас II в растеж има съмнение за сътрудничеството.

Коя опция намалява зависимостта от сътрудничеството?

A) Фиксиран функционален апарат

B) Подвижен функционален апарат

C) Ластици клас II

D) Нощна плака

Въпрос 59

СЛУЧАЙ

20 г. ANB 9°, overjet 11 mm, изразена мандибуларна ретрузия, оплакване от профила.

Кой е най-подходящият подход?

A) Само ластици клас II

B) Функционален апарат

C) Само IPR

D) Консултация за ортогнатна хирургия

Въпрос 60

СЛУЧАЙ

При камуфлаж на клас II горните резци се изтеглят назад.

На какво се обръща най-голямо внимание?

A) Максимално изправяне на резците

B) Максимално увеличаване на силата

C) На контрола на торка; избягване на прекомерна ретроклинация на резците

D) Задълбочаване на overbite

Блок 6 · Отговори и коментари

ВЪПРОС	ОТГОВОР	КОМЕНТАР
51	**D**	**Дентален.** При нормален ANB съотношението клас II се обяснява с позицията на зъбите.
52	**C**	**Функционален апарат.** Мандибуларната ретрузия, нормалният вертикален модел и подходящият период на растеж са благоприятни условия за функционален апарат.
53	**B**	**Оценка за ранно намаляване на overjet.** Увеличеният overjet и анамнезата за травма са силни основания за ранна намеса.
54	**A**	**Проклинация на долните резци.** При функционалните апарати долните резци имат склонност към проклиниране; трябва да се проследява.
55	**D**	**Екструзия на долните молари и проклинация на долните резци.** Ластиците клас II изтеглят долната дъга напред и могат да екструдират долните молари.
56	**C**	**Нужно е внимание; екструзията на моларите може да ротира мандибулата назад и да влоши профила.** Хипердивергентният модел е чувствителен към механики, които предизвикват екструзия.
57	**B**	**Корекция на инклинацията на горните централни резци и отваряне на дълбоката захапка.** Без корекция на ретроклинираните резци и дълбоката захапка сагиталното съотношение не може да се отчете правилно.
58	**A**	**Фиксиран функционален апарат.** Фиксираните функционални апарати не зависят от това дали пациентът ги поставя и сваля.
59	**D**	**Консултация за ортогнатна хирургия.** При голямо скелетно несъответствие със завършен растеж границите на камуфлажа се надхвърлят.
60	**C**	**На контрола на торка; избягване на прекомерна ретроклинация на резците.** Загубата на торк влияе неблагоприятно както на естетиката, така и на overbite.

Верни отговори: ___ / 10 Дата: Дата на повторение:

БЛОК 7 · ВЪПРОСИ 61–70

Клас III

За четене: Модул 05 · Визуални карти 13, 73–76

Въпрос 61

СЛУЧАЙ

7 г. Предна кръстосана захапка. В централна релация резците са ръб в ръб. В покой профилът е прав.

Каква е най-вероятната диагноза?

A) Скелетен клас III

B) Клас II, подклас 2

C) Псевдо клас III

D) Ножицовидна захапка

Въпрос 62

СЛУЧАЙ

8 г. SNA 77°, SNB 80°, ANB −3°. Отрицателен overjet.

Коя опция може да се обмисли?

A) Незабавна ортогнатна хирургия

B) Ранна протракция на максилата с лицева маска

C) Ластици клас II

D) Екстракция на долни премолари

Въпрос 63

СЛУЧАЙ

9 г. Бащата е с клас III. ANB −2°.

Какво трябва да се обясни на семейството?

A) Възможната полза от ранното лечение, че с растежа може да има рецидив и че по-късно може да е нужно допълнително лечение

B) Че ранното лечение ще реши проблема окончателно и трайно

C) Че никое лечение няма да помогне

D) Че е само естетичен проблем

Въпрос 64

СЛУЧАЙ

Възрастен. ANB −2°, профилът е приемлив, пациентът не желае хирургия.

Как се движат резците при камуфлаж?

A) Горните резци се накланят назад, долните — напред

B) И двата резеца се изправят

C) Резците не се движат

D) Горните резци се накланят напред, долните — назад

Въпрос 65

СЛУЧАЙ

Ортодонтска подготовка преди ортогнатна хирургия при клас III.

Каква е целта на подготвителната фаза?

A) Увеличаване на компенсацията

B) Пълно затваряне на отрицателния overjet

C) Декомпенсация: резците се довеждат до правилна инклинация спрямо базалната кост

D) Корекция дотам, че хирургията да не е нужна

Въпрос 66

СЛУЧАЙ

Използват се ластици клас III.

Кой е типичният страничен ефект?

A) Проклинация на долните резци

B) Проклинация на горните резци, ретроклинация на долните резци и екструзия на горните молари

C) Интрузия на горен молар

D) Увеличаване на overjet

Въпрос 67

СЛУЧАЙ

Планира се лечение с лицева маска.

Кой е най-подходящият период?

A) Ранно смесено съзъбие, докато максиларният растеж продължава

B) След завършване на растежа

C) Само в зряла възраст

D) Години след пробива на постоянните втори молари

Въпрос 68

СЛУЧАЙ

26 г. Един горен латерален резец е в кръстосана захапка. В дъгата липсват около 2 mm място.

Каква трябва да е последователността на корекцията?

A) Първо резецът се изтласква насила лабиално

B) Ортогнатна хирургия

C) Да не се прави нищо

D) Първо се отваря място, след това резецът се придвижва лабиално

Въпрос 69

СЛУЧАЙ

Предна кръстосана захапка.

Коя находка предполага истински скелетен клас III?

A) Резците застават ръб в ръб в централна релация

B) Само един резец е в кръстосана захапка

C) Отрицателният overjet остава и в централна релация, конкавен профил и фамилна анамнеза

D) Прав профил и функционално изместване

Въпрос 70

СЛУЧАЙ

15 г., момче. Скелетен клас III, обмисля се хирургия. Растежът продължава.

Как се определя времето за хирургията?

A) Прави се веднага, докато растежът продължава

B) Изчаква се завършването на растежа; потвърждава се със серийни записи

C) Планира се за един и същи ден независимо от възрастта

D) Времето не влияе на резултата

Блок 7 · Отговори и коментари

ВЪПРОС	ОТГОВОР	КОМЕНТАР
61	**C**	**Псевдо клас III.** Контактът ръб в ръб в централна релация и правият профил предполагат функционално предно изместване.
62	**B**	**Ранна протракция на максилата с лицева маска.** При максиларна ретрузия ранната протракция се оценява в периода на растеж.
63	**A**	**Възможната полза от ранното лечение, че с растежа може да има рецидив и че по-късно може да е нужно допълнително лечение.** При фамилен клас III растежът може да промени резултата; очакванията се поставят правилно още от началото.
64	**D**	**Горните резци се накланят напред, долните — назад.** Камуфлажът прикрива скелетното несъответствие с дентоалвеоларна компенсация; границите му се спазват.
65	**C**	**Декомпенсация: резците се довеждат до правилна инклинация спрямо базалната кост.** По време на декомпенсацията отрицателният overjet може временно да се увеличи; пациентът се информира предварително.
66	**B**	**Проклинация на горните резци, ретроклинация на долните резци и екструзия на горните молари.** Ластиците клас III изтеглят горната дъга напред, а долната — назад.
67	**A**	**Ранно смесено съзъбие, докато максиларният растеж продължава.** Скелетният ефект на протракцията е по-голям в ранния период.
68	**D**	**Първо се отваря място, след това резецът се придвижва лабиално.** Без място зъбът не може да се включи в дъгата; при нужда се добавят временни повдигащи захапката елементи.
69	**C**	**Отрицателният overjet остава и в централна релация, конкавен профил и фамилна анамнеза.** При псевдо клас III в централна релация е възможен контакт ръб в ръб; при истински клас III — не.
70	**B**	**Изчаква се завършването на растежа; потвърждава се със серийни записи.** При операция по време на растеж последващият мандибуларен растеж може да наруши резултата.

Верни отговори: ___ / 10 Дата: Дата на повторение:

БЛОК 8 · ВЪПРОСИ 71–80

Вертикални и трансверзални проблеми

За четене: Модул 06 · Визуални карти 4–6, 79–92

Въпрос 71

СЛУЧАЙ

9 г. Навик за смучене на палец. Предна отворена захапка 3 mm. FMA 26°.

Кой е най-вероятният тип и коя е първата цел?

A) Скелетна отворена захапка; ортогнатна хирургия

B) Дентална отворена захапка, свързана с навик; първо — отказване от навика

C) Функционално изместване; RME

D) Дълбока захапка; интрузия

Въпрос 72

СЛУЧАЙ

14 г. FMA 36°, увеличена предна долна лицева височина, предна отворена захапка 4 mm.

Какво предполага тази картина?

A) Скелетна отворена захапка; приоритет е вертикалният контрол

B) Само дентална отворена захапка

C) Хиподивергентен модел

D) Тенденция към дълбока захапка

Въпрос 73

СЛУЧАЙ

11 г. При преглъщане езикът е между резците. Нарушено произнасяне на звука „с“. Отворена захапка 2 mm.

Кой е най-подходящият подход?

A) Затваряне само с вертикални ластици

B) Изчакване, без да се прави нищо

C) Екстракция на премолари

D) Мултидисциплинарен план с логопед, при нужда езикова решетка

Въпрос 74

СЛУЧАЙ

Overbite 6 mm. В покой горните резци се виждат прекомерно. При усмивка се вижда гингива.

Как трябва да се отвори дълбоката захапка?

A) Екструзия на горните резци

B) Само задна екструзия

C) Предимно интрузия на горните резци

D) Ластици клас II

Въпрос 75

СЛУЧАЙ

Overbite 6 mm. В покой горните резци се виждат малко. FMA 20°.

Коя опция е по-подходяща?

A) Интрузия на горните резци

B) Задна екструзия и/или интрузия на долните резци

C) Задна интрузия

D) Без никаква вертикална механика

Въпрос 76

СЛУЧАЙ

24 г. Само горният ляв първи молар е в кръстосана захапка. Ширината на горната дъга е достатъчна.

Кой е най-подходящият подход?

A) Локална дентална корекция

B) Бързо разширение на горната челюст

C) Хирургично асистирано разширение

D) Лицева маска

Въпрос 77

СЛУЧАЙ

За кръстосана захапка на един молар се използва кръстосан ластик.

Кой е типичният страничен ефект?

A) Интрузия на зъбите

B) Проклинация на резците

C) Корекция на средната линия

D) Екструзия на зъбите

Въпрос 78

СЛУЧАЙ

Горните странични зъби затварят изцяло букално от долните.

Как се нарича тази захапка?

A) Задна кръстосана захапка

B) Отворена захапка

C) Ножицовидна захапка

D) Функционално изместване

Въпрос 79

СЛУЧАЙ

18 г. Двустранна задна кръстосана захапка. Тънък гингивален фенотип, премоларите вече са наклонени букално.

Коя опция е по-безопасна?

A) Още по-голямо букално накланяне на зъбите

B) Оценка на опциите за скелетно разширение с мнение на пародонтолог

C) Продължително използване на кръстосани ластици

D) Без никаква оценка

Въпрос 80

СЛУЧАЙ

При усмивка се вижда много гингива. Клиничните коронки са къси. Видимостта на резците е нормална.

Каква причина трябва да се обмисли?

A) Пасивен пробив; пародонтологична оценка

B) Вертикалният максиларен излишък е категоричната диагноза

C) Мандибуларна прогнатия

D) Функционално изместване

Блок 8 · Отговори и коментари

ВЪПРОС	ОТГОВОР	КОМЕНТАР
71	**B**	**Дентална отворена захапка, свързана с навик; първо — отказване от навика.** При нормален вертикален модел отворената захапка, съчетана с навик, най-често е дентална.
72	**A**	**Скелетна отворена захапка; приоритет е вертикалният контрол.** Високият FMA и увеличената предна долна лицева височина показват скелетен компонент.
73	**D**	**Мултидисциплинарен план с логопед, при нужда езикова решетка.** Отворена захапка, затворена без лечение на мускулната функция, е склонна към рецидив.
74	**C**	**Предимно интрузия на горните резци.** Голямата видимост на резците прави интрузията на горните резци естетически предпочитана.
75	**B**	**Задна екструзия и/или интрузия на долните резци.** При малка видимост на резците горната интрузия влошава усмивката; нискоъгловият модел толерира задна екструзия.
76	**A**	**Локална дентална корекция.** Кръстосаната захапка на един зъб при достатъчна ширина на дъгата показва дентален проблем.
77	**D**	**Екструзия на зъбите.** Вертикалният компонент на кръстосаните ластици екструдира зъбите; проследява се особено при хипердивергентен пациент.
78	**C**	**Ножицовидна захапка.** При ножицовидна захапка контактът в букално-лингвална посока е напълно загубен.
79	**B**	**Оценка на опциите за скелетно разширение с мнение на пародонтолог.** При компенсаторно наклонени зъби допълнителното дентално разширение повишава пародонталния риск.
80	**A**	**Пасивен пробив; пародонтологична оценка.** Късите клинични коронки и нормалната видимост на резците предполагат пасивен пробив.

Верни отговори: ___ / 10 Дата: Дата на повторение:

БЛОК 9 · ВЪПРОСИ 81–90

Помощни механики

За четене: Модул 07 · Визуални карти 93–104

Въпрос 81

СЛУЧАЙ

При затваряне на пространствата overbite в резците се задълбочава и торкът се губи. Дъгата е малка, силата е голяма.

Какво трябва да се промени?

A) Намаляване на силата, преминаване към правоъгълна стоманена дъга, която по-добре запълва слота, и контрол на торка

B) Още по-голямо увеличаване на силата

C) Преминаване към по-тънка кръгла дъга

D) Пренебрегване на задълбочаването на overbite

Въпрос 82

СЛУЧАЙ

Ще започне затваряне на пространствата с плъзгаща механика.

Кое е условието преди започване?

A) Гъвкавата NiTi дъга остава на място

B) Брекетите още не са поставени изцяло

C) Поставен е ретенционен апарат

D) Завършено нивелиране и подходяща правоъгълна работна дъга

Въпрос 83

СЛУЧАЙ

Обмисля се механика с примки (loop).

Кое е основното предимство?

A) Не изисква никакво активиране

B) Улеснява хигиената

C) Липса на триене; силата и моментът се регулират чрез геометрията на огъването

D) Зависи от сътрудничеството на пациента

Въпрос 84

СЛУЧАЙ

Коригиран е латерален резец с изразена ротация.

Коя е основната причина за рецидив на ротацията?

A) Промяна на цвета на брекетите

B) Късно ремоделиране на супракресталните гингивални влакна

C) Увеличаване на overjet

D) Без мини винт

Въпрос 85

СЛУЧАЙ

Палатинално ретиниран горен кучешки зъб. Има място, позицията е определена.

Кое е важно преди тракцията?

A) Ригидна анкоражна единица и посока на силата, планирана далеч от съседните корени

B) Силата да е възможно най-голяма

C) Оставяне на анкоражните зъби на гъвкава дъга

D) Отказ от допълнителна образна диагностика

Въпрос 86

СЛУЧАЙ

При тракция на ретиниран кучешки зъб няма движение въпреки изминалите месеци, а анкоражните зъби се интрудират.

Какво трябва да се обмисли?

A) Удвояване на силата

B) Пренебрегване на интрузията на анкоражните зъби

C) Преминаване към ретенция

D) Съмнение за анкилоза; подробна оценка (Ръководство 4)

Въпрос 87

СЛУЧАЙ

Долният втори молар се изправя.

Кой е типичният страничен ефект?

A) Интрузия на молара

B) Ретроклинация на резците

C) Екструзия на молара и преждевременен оклузален контакт

D) Задна кръстосана захапка

Въпрос 88

СЛУЧАЙ

В горната дъга е нужно леко до умерено дентоалвеоларно разширение и деротация на моларите.

Кой апарат е подходящ?

A) Лицева маска

B) Quad helix

C) Twin Block

D) Фиксиран лингвален ретейнер

Въпрос 89

СЛУЧАЙ

Направена е дистализация на горните молари с Pendulum.

Кой е очакваният страничен ефект?

A) Мезиално придвижване на премоларите и резците; дистално накланяне (tipping) на моларите

B) Ретроклинация на резците

C) Мезиално накланяне (tipping) на моларите

D) Разширение на долната дъга

Въпрос 90

СЛУЧАЙ

Фрактура на горен централен резец, стигаща под гингивата. Дължината на корена е достатъчна. Нужна е граница за възстановяване.

Какъв може да е ортодонтският принос?

A) Ортодонтска интрузия

B) Бързо разширение на горната челюст

C) Ластици клас III

D) Ортодонтска екструзия (форсирано изваждане)

Блок 9 · Отговори и коментари

ВЪПРОС	ОТГОВОР	КОМЕНТАР
81	**A**	**Намаляване на силата, преминаване към правоъгълна стоманена дъга, която по-добре запълва слота, и контрол на торка.** Неригидната дъга и прекомерната сила водят до неконтролирано накланяне на резците назад.
82	**D**	**Завършено нивелиране и подходяща правоъгълна работна дъга.** Затварянето на пространствата преди края на нивелирането води до загуба на контрола над торка и ротацията.
83	**C**	**Липса на триене; силата и моментът се регулират чрез геометрията на огъването.** Примките премахват проблема с триенето, но изискват прецизно огъване и активиране.
84	**B**	**Късно ремоделиране на супракресталните гингивални влакна.** Супракресталните влакна остават опънати дълго; оценяват се ретенцията и при нужда фибротомия.
85	**A**	**Ригидна анкоражна единица и посока на силата, планирана далеч от съседните корени.** При грешна посока на силата рискът от резорбция на съседните корени се повишава.
86	**D**	**Съмнение за анкилоза; подробна оценка (Ръководство 4).** Липсата на движение и страничният ефект върху анкоражните зъби предполагат анкилоза.
87	**C**	**Екструзия на молара и преждевременен оклузален контакт.** При изправяне ротацията около мезиалния апекс издига молара.
88	**B**	**Quad helix.** Quad helix се използва за леко до умерено дентално разширение и деротация на моларите.
89	**A**	**Мезиално придвижване на премоларите и резците; дистално накланяне (tipping) на моларите.** Анкоражната единица се придвижва напред; моларите могат неконтролирано да се наклонят дистално.
90	**D**	**Ортодонтска екструзия (форсирано изваждане).** Екструзията извежда линията на фрактурата над гингивата и улеснява възстановяването.

Верни отговори: ___ / 10 Дата: Дата на повторение:

БЛОК 10 · ВЪПРОСИ 91–100

Финиширане, ретенция, травма и анкилоза

За четене: Модул 08 · Визуални карти 20, 105–114 · Ръководство 2 · Ръководство 4

Въпрос 91

СЛУЧАЙ

При финиширането нивата на маргиналните гребени на съседните зъби се различават.

Какво се прави?

A) Незабавно сваляне на брекетите

B) Увеличаване на силата

C) Опит разликата да се коригира с ретенцията

D) Препозициониране на съответните брекети

Въпрос 92

СЛУЧАЙ

Във фазата на финиширане проверявате паралелността на корените.

Кой е правилният подход?

A) Оценка само на вида на коронката

B) Без никаква рентгенография

C) Оценка на панорамната снимка, като се има предвид изкривяването и се тълкува заедно с клиничните находки

D) Приемане на панорамната снимка като точно измерване

Въпрос 93

СЛУЧАЙ

Финиширане. Долната средна линия е изместена 2 mm надясно. Няма скелетна асиметрия и функционално изместване.

Каква механика е подходяща?

A) Ортогнатна хирургия

B) Дентална корекция с асиметрична механика или асиметрични ластици

C) Бързо разширение на горната челюст

D) Без никаква корекция

Въпрос 94

СЛУЧАЙ

Съотношенията на резците са добри, но задните контакти в премоларната зона са слаби.

Кой метод може да се използва?

A) Оклузално наместване с гъвкава финишна дъга или краткосрочни вертикални ластици

B) Увеличаване на силата без сваляне на брекетите

C) Бързо разширение на горната челюст

D) Задна интрузия

Въпрос 95

СЛУЧАЙ

В началото имаше горна диастема и ротации на долните резци.

Каква ретенция се препоръчва?

A) Не е нужна ретенция

B) Само един месец подвижна плака

C) Само препоръка за устна хигиена

D) Фиксиран лингвален ретейнер, при нужда заедно с нощна плака

Въпрос 96

СЛУЧАЙ

Пациент със слаба хигиена, който не иска фиксиран лингвален ретейнер, но сътрудничи.

Коя опция може да се обмисли?

A) Без никаква ретенция

B) Ортогнатна хирургия

C) Подвижна ретенция (Hawley или прозрачна плака) и близко проследяване

D) Поставяне на фиксиран лингвален ретейнер въпреки желанието на пациента

Въпрос 97

СЛУЧАЙ

Три години след края на лечението скупчеността на долните резци се е върнала. Плаките са спрени.

Кое е най-вероятното обяснение?

A) Лечението изобщо не е подействало

B) Неспазване на ретенцията и продължаващи с възрастта физиологични промени

C) Само несъответствие по Bolton

D) Само проблем на ТМС

Въпрос 98

СЛУЧАЙ

На контролния преглед се установява, че една от връзките на фиксирания лингвален ретейнер е откъсната. Пациентът не е забелязал.

Какво се прави?

A) Ранна поправка и проверка дали в тази зона има движение на зъби

B) Изчакване до следващия годишен контрол

C) Пълно премахване на ретенцията без предлагане на алтернатива

D) Находката не се документира

Въпрос 99

СЛУЧАЙ

10 г. Анамнеза за травма на горен централен резец. Планира се ортодонтско лечение.

Какво се прави в началото?

A) Анамнезата за травма не се документира

B) Прилагане на максимална сила върху травмирания зъб

C) Започване на лечение без оценка

D) Клинична и рентгенологична оценка на травмирания зъб и документиране; план с леки сили

Въпрос 100

СЛУЧАЙ

Млечният молар е в инфраоклузия, съседните зъби са се наклонили над него. Няма подлежащ постоянен зъб.

Кои са най-вероятната диагноза и подход?

A) Нормален пробив; само изчакване

B) Функционално изместване

C) Анкилоза; навременно екипно решение с оглед на мястото и нивото на костта

D) Ластици клас II

Блок 10 · Отговори и коментари

ВЪПРОС	ОТГОВОР	КОМЕНТАР
91	**D**	**Препозициониране на съответните брекети.** Разликата в маргиналните гребени изисква корекция на позицията на брекета.
92	**C**	**Оценка на панорамната снимка, като се има предвид изкривяването и се тълкува заедно с клиничните находки.** Панорамната снимка е ориентировъчна, но може да съдържа изкривяване.
93	**B**	**Дентална корекция с асиметрична механика или асиметрични ластици.** Отклонението на средната линия с дентален произход може да се коригира с дентална механика.
94	**A**	**Оклузално наместване с гъвкава финишна дъга или краткосрочни вертикални ластици.** Settling подобрява задните контакти.
95	**D**	**Фиксиран лингвален ретейнер, при нужда заедно с нощна плака.** Диастемата и ротациите са находки с висок риск от рецидив.
96	**C**	**Подвижна ретенция (Hawley или прозрачна плака) и близко проследяване.** Ретенцията се избира заедно с хигиената, сътрудничеството и предпочитанието на пациента.
97	**B**	**Неспазване на ретенцията и продължаващи с възрастта физиологични промени.** Зъбите имат склонност към движение през целия живот; затова ретенцията се планира дългосрочно.
98	**A**	**Ранна поправка и проверка дали в тази зона има движение на зъби.** Ако откъснатата връзка не бъде забелязана, може да настъпи нежелано движение на зъбите.
99	**D**	**Клинична и рентгенологична оценка на травмирания зъб и документиране; план с леки сили.** Травмираните зъби се оценяват и документират преди лечението; подробности в Ръководство 4.
100	**C**	**Анкилоза; навременно екипно решение с оглед на мястото и нивото на костта.** Забавянето при анкилозирал млечен молар може да доведе до накланяне на съседните зъби и до разлика в нивото на костта.

Верни отговори: ___ / 10 Дата: Дата на повторение:

С образователна цел. Този материал не замества клиничния преглед, решението на лекаря и мнението на специалист.

Следваща стъпка

Решихте ли всичките 100 въпроса? Изберете двата блока с най-малко верни отговори и се върнете към съответните седмици от 52-седмичната програма за работа по случаи.

Ако в блока по цефалометрия имате под 8 верни отговора, отворете **Тетрадка за упражнения по цефалометрични измервания**. За да обсъдите собствените си случаи с колеги, използвайте **Шаблони за представяне на случаи пред колеги**.

За да ускорите решенията на стола, дръжте под ръка от Библията **Инструмент 2 · Карта за решение: екстракция или запазване?** и **Инструмент 3 · Визуален детектор: клас II срещу клас III**.